

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

DISFUNCIÓN SEXUAL POR PSICOFÁRMACOS (PRSEXDQ - SALSEX)

Eje VI: Farmacovigilancia y Sexualidad • Detección Breve de Toxicidad Sexual de Ángel L. Montejo

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Disfunción Sexual Secundaria a Psicofármacos (SALSEX / PRSexDQ).
Nombre Original	Psychotropic-Related Sexual Dysfunction Questionnaire (PRSexDQ-SALSEX; Montejo et al., 2000).
Autores Originales	Ángel L. Montejo, M.D., Ph.D., G. Llorca, J. A. Izquierdo y F. Rico-Villademoros (Consortio Español).
Ámbito de Validación	España e internacional; Universidad de Salamanca / Hospital Universitario de Salamanca.
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Somática y Efectos Secundarios. Disfunción sexual iatrogénica por antidepresivos y antipsicóticos.
Tipo de Instrumento	Entrevista clínica estructurada heteroaplicada breve (o autoinforme supervisado).
Composición de Ítems	5 reactivos que evalúan deseo, retraso del clímax, anorgasmia, erección/lubricación y tolerancia.
Población y Rango	Hombres y mujeres adultos (≥ 18 años) en tratamiento psicofarmacológico activo.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos de administración dinámica e integrada en la entrevista médica.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico asistencial y proyectos de investigación académica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL TABÚ DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL IATROGÉNICA

El cuestionario **SALSEX (PRSexDQ)** fue creado por el equipo de Ángel Montejo para visibilizar una de las principales causas de abandono del tratamiento psiquiátrico:

- La Paradoja del Subregistro:** Menos del 20% de los pacientes que toman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) o antipsicóticos reportan espontáneamente disfunción sexual; sin embargo, cuando se aplica el SALSEX, la prevalencia real supera el **60-70%**.
- Exploración de la Respuesta Sexual Completa:** Evalúa las tres fases cardinales del ciclo sexual (deseo, excitación eréctil/lubricación y orgasmo/eyaculación), permitiendo identificar si el problema es de retraso o anorgasmia completa.
- Alerta de Abandono Terapéutico:** Su quinto ítem mide explícitamente el grado de tolerancia del paciente y si la disfunción está motivando el abandono unilateral de los fármacos.

3. LOS 5 REACTIVOS CARDINALES DEL PROTOCOLO SALSEX

Fase del Ciclo Sexual	Rango	Definición Operativa del Reactivo Clínico
1. Deseo Sexual / Libido	0 a 3 puntos	Disminución o pérdida del apetito sexual en comparación con el estado previo al fármaco.
2. Retraso en el Orgasmo	0 a 3 puntos	Dificultad o retardo significativo en alcanzar el clímax o eyaculación durante la relación.
3. Anorgasmia / Eyacu- lación	0 a 3 puntos	Incapacidad total para alcanzar el orgasmo (anorgasmia) o ausencia de eyaculación.
4. Excitación / Erección	0 a 3 puntos	Dificultad en conseguir o mantener la erección (varones) o lubricación vaginal (mujeres).
5. Aceptabilidad / Toleran- cia	0 a 3 puntos	Grado de malestar subjetivo y si la disfunción motiva el planteamiento de dejar la medicación.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las validaciones clínicas multicéntricas (Montejo et al., 2000, 2008, 2019; $N > 1000$) corroboran su alta precisión:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.87 - 0.91	Excelente homogeneidad en los reactivos del ciclo sexual.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.92 (a 1 semana)	Gran estabilidad temporal en tratamientos farmacológicos a dosis fijas.
Sensibilidad en ISRS	Sensibilidad = 92%	Detección exhaustiva de anorgasmia y retraso eyaculatorio serotoninérgico.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 86%	Distingue la disfunción iatrogénica de la inhibición sexual por depresión.
Sensibilidad al Cambio	Efecto $d = 1.45$ (rotación)	Captura nítida de la recuperación tras cambio a bupropión, agomelatina o vortioxetina.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Calificación de los Ítems (1 al 5):** Cada ítem se puntúa de 0 a 3: 0 = Ningún problema; 1 = Leve; 2 = Moderado; 3 = Severo.
- **Cálculo de la Puntuación Total SALSEX:** Suma directa de los 5 reactivos:

$$\text{Puntuación Total SALSEX} = \sum_{i=1}^5 \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 15 puntos})$$

- **Direccionalidad Clínica:** A mayor puntuación, mayor gravedad de la disfunción sexual inducida y mayor riesgo de interrupción del tratamiento.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Total	Ítem 5 (Tolerancia)	Significación Clínica y Conducta Terapéutica (Montejo)
Sin Disfunción	0 a 1 puntos	0 (Sin queja)	Función sexual normal preservada; mantener tratamiento.
Disfunción Leve	2 a 5 puntos	1 (Bien tolerado)	Alteración leve tolerable; el paciente no planea suspender.
Disfunción Moderada	6 a 10 puntos	2 (Mala tolerancia)	Punto de corte clínico interferencia conyugal; riesgo de abandono.
Disfunción Severa	11 a 15 puntos	3 (Abandono)	Intolerable anorgasmia total o impotencia; cambio farmacológico urgente.

ALERTA CLÍNICA DEL ÍTEM 5 (RIESGO DE INCUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO):

El ítem 5 es el marcador de alarma más potente del cuestionario. Una puntuación de **2 o 3 en el ítem 5** (el paciente afirma que la disfunción sexual afecta gravemente a su pareja o que se plantea dejar la medicación) predice un **abandono no consensuado superior al 80%** en los siguientes 3 meses si el clínico no ofrece una alternativa terapéutica activa.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN CLÍNICA ANTE DISFUNCIÓN SEXUAL IATROGÉNICA

PROTOCOLO DE RESCATE SEXUAL CON EL CUESTIONARIO SALSEX:

- **Paso 1 (Cribado Proactivo Dirigido):** Interrogar directamente el SALSEX a las 4 y 8 semanas de iniciar cualquier antidepresivo (ISRS/IRSN) o antipsicótico.
- **Paso 2 (Análisis del Patrón Específico de Disfunción):**
 - *Retraso eyaculatorio o Anorgasmia pura con deseo conservado:* Mecanismo serotoninérgico puro mediado por receptores 5-HT_{2A}.
 - *Pérdida de deseo y anorgasmia con galactorrea o amenorrea en antipsicóticos:* Mecanismo por hiperprolactinemia; solicitar prolactina sérica.
- **Paso 3 (Estrategias Médicas Validadas):**
 - *Estrategia 1 (Rotación):* Cambiar a fármacos con bajo impacto sexual: **Bupropión** (dopamina/noradrenalina), **Vortioxetina** o **Agomelatina**.
 - *Estrategia 2 (Potenciación Coadyuvante):* Añadir Bupropión (150 mg/día) o inhibidores de la PDE-5 (**Sildenafil**, **Tadalafilo**) a demanda si la depresión está estabilizada con el ISRS actual.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: ANORGASMIA POR PAROXETINA Y RESCATE CON BUPROPIÓN

Identificación: Varón de 36 años, economista, en tratamiento con Paroxetina 20 mg/día por un trastorno de ansiedad generalizada y ataques de pánico desde hace 3 meses, logrando una remisión completa de la ansiedad. Consulta con tono avergonzado porque "su vida de pareja se está rompiendo".

Evaluación Estructurada con el Cuestionario SALSEX:

• **Puntuación Total SALSEX = 11 / 15 puntos (Disfunción Severa, mala tolerancia crítica).**

Desglose de Ítems:

- Ítem 1 (Deseo): 1 punto (deseo levemente conservado).
- Ítem 2 (Retraso orgasmo): **3 puntos** (severo retraso; requiere más de 45 minutos de estimulación).
- Ítem 3 (Anorgasmia): **3 puntos** (en el 80% de los intentos es incapaz de eyacular, terminando con dolor y frustración).
- Ítem 4 (Erección): 1 punto (erección preservada).
- Ítem 5 (Tolerancia): **3 puntos** ("Me planteo seriamente dejar las pastillas ya mismo").

Conducta Médica Adoptada: Se validó la queja del paciente evitando minimizar el síntoma. Se acordó la transición gradual de Paroxetina hacia Bupropión 150 mg/día (liberación modificada) asociado temporalmente a Tadalafilo 10 mg a demanda.

Evolución: A las 4 semanas del cambio, la puntuación SALSEX se redujo a **1 punto** (anorgasmia resuelta, tiempo de latencia eyaculatoria normalizado en 7 minutos), manteniéndose la estabilidad emocional y evitando el abandono del tratamiento psiquiátrico.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DISFUNCIÓN SEXUAL POST-ISRS (PSSD):

Informar al paciente de que en raras ocasiones la anorgasmia y el entumecimiento genital pueden persistir tras suspender el antidepresivo.

NO RECOMENDAR "VACACIONES DE FIN DE SEMANA":

Omitir dosis de ISRS los fines de semana para tener sexo provoca abstinencia aguda y fluctuaciones anímicas desestabilizadoras.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Montejo, A. L., Llorca, G., Izquierdo, J. A., & Rico-Villademoros, F. (2001). Incidence of sexual dysfunction associated with antidepressant agents: A prospective multicenter study of 1022 patients. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 62(Suppl 3), 10-21.
2. Montejo, A. L., et al. (2008). Psychometric properties of the Psychotropic-Related Sexual Dysfunction Questionnaire (PRSexDQ-SALSEX). *Actas Españolas de Psiquiatría*, 36(6), 332-341.
3. Montejo, A. L., et al. (2019). Management of antidepressant-induced sexual dysfunction: Spanish consensus recommendations. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental*, 12(3), 167-179.
4. Clayton, A. H., et al. (2014). Prevalence and treatment of sexual dysfunction in patients with depression. *Current Psychiatry Reports*, 16(11), 513.